



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 22-01-2026 12:14:18

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre	: Luis Armando Orellana Barros	Rut	: 6.203.128-K	N° Archivo	: 1227749	N° Epicrisis	
Edad	: 76a 2m 29d	Fecha Nacto	: 24/10/1949	Sexo	: Masculino	469660	
Dirección	: Av. Principal 0478 San Guillermo	Comuna	: Puente Alto	Teléfono	: 9 5690 1423		

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso	: Unidad Intermedio Coronaria	Fecha Ingreso	: 16/01/2026	08:12	Días Estadía	: 6
Unidad de Egreso	: Unidad Intermedio Coronaria	Fecha Egreso	: 22/01/2026	12:01		

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolro al pecho

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

Ingreso UCO

Antecedentes

Médicos: HTA, DM2 IR, carcinoma escamoso de la cabeza operado, FA paroxística en TACO , pancreatitis complicada 2013 (pseudoquistes)

Med: Insulina NPH 10 UI c/12 hr, metformina 850 mg cada 8 horas, amlodipino 5 mg al día, enalapril 10 mg cada 12 horas, acenocumarol, bisoprolol 5 mg 1/2 al día

Qx: Colecistostomía (año 2024), Colecistectomía parcial abierta por colecistitis aguda perforada y reexploración por biliperitoneo (2013), cisto gastroanastomosis endoscópica (2013) resección de carcinoma escamoso con parotidectomía izquierda y disección cervical izquierda (2023).

Alergias: (-)

Hábitos: OH (-) TBQ (-) Drogas (-)

Hospitalizaciones recientes: Agosto 2024 sepsis de foco biliar con compromiso multiorgánico (IOT, SLED)

Vacunas: Al día 2025

Social: Vive con su señora, hija y nieto. Usuario de bastón para movilización y burrito. Autovalente.

Rescato ETT 06/25 FEVI 68%, dilatación severa AI -> estudio realizado debut FA paroxística 05/2025.

Paciente presenta DREO con irradiación a todo tórax anterior, hombro derecho y torax lateral / dorsal derecho. Ocurre el día miércoles 14/01 en la noche, 4 horas de duración, sin náuseas, vómitos, sudoración, disnea, lipotimia o síncope. Sin otros síntomas agregados. Sin nuevos episodios de dolor torácico desde entonces. Sin disnea en reposo. Sin dolores semanas o meses previos.

ECG APS y HSR iguales: RS, eje normal, QRS angosto, QS v1 a v3 con mala progresión de R en precordiales, SDST <1mm lateral con onda T negativa V4-V6, DI y aVL.

ECG UCO sin cambios a lo descrito pero con EV aisladas monomorfa frecuente con intervalo acoplamiento 400ms (R sobre T)

Ingresa a UCO en buenas condiciones, sin dolor, sin disnea, tolera decúbito.

Exámenes 16/01

TUS 22175

Hb 11.4, GB 7150 (66% PMN), plaq 162000, Crea 1.5 (48 ml/min), BUN 26, ELP 141/4.62/105, glucosa 356, PCR 60

INR 1.79 (acenocumarol), TTPA 36

Fecha Epicrisis : 22/01/2026 12:14

Fecha Última Actualización: 22-01-2026 12:14:18

Página 2 de 3

Ecocopia: FEVI <40%, acinesia anteroseptal completa, hipocinesia anterior medio-apical, inferoseptal medio-apical, y todos los segmentos apicales. Sin valvulopatías significativas. Al dilatada. Sin dilatación de VD, FSVD conservada. Sin derrame pericárdico. Escasas líneas B anterolaterales > en bases simétricas. Sin derrame pleural. VCI >50% variabilidad.

Dxs:

Infarto agudo al miocardio

- Probable infarto consolidado de territorio ADA

Insuficiencia cardíaca probable etiología isquémica

Falla renal, crónica (crea 2025 1.5 y 2024 en 0.9)

FA paroxística en TACO.

EL PACIENTE PERMANECIÓ 7 días de hospitalización.

Con los diagnósticos de:

1. IAM transmural consolidado Anterior

2. Insuficiencia cardíaca de etiología isquémica con fevi moderadamente reducida. ProBNP 5501 (17/01)

- Ecocardiograma 19/01: Acinesia de los segmentos apicales del ventrículo izquierdo. FEVI 43%. FSG levemente reducida.

3. Fibrilación auricular paroxística en TACO

4. Enfermedad renal crónica

- Basal: 2024 Crea 0.9; 2025 Crea 1.5 VGF 46

5. DM2 IR (HbA1c 7.1)

6. Comorbilidades: HTA, Carcinoma escamoso de cabeza operado, Pancreatitis complicada 2013 (pseudoquiste) y cistogastroanastomosis endoscópica (2013). ERC

LUEGO DE SU INGRESO, se mantuvo asintomático, hemodinamicamente estable. En CNG del 19/1/26 se apreció: TCI: sin lesiones. ADA: De buen calibre y desarrollo, obstrucción de 80% severamente calcificada en su porción media. Ramo diagonal subocluido-ocluido. ACx: De buen calibre y desarrollo, obstrucción de 60% segmento medio. ACD: sin lesiones.

Conclusiones: ADA severa enferma en su porción proximal media. Se decidió nueva coronariografía el 21 01 2026 para PTCA con eventual aterectomía rotacional, sin embargo, se realizó sin necesidad de rotabrador, obteniendo buen flujo TIMI y evoluicon clínica satisfactoria, por lo que se decide el alta el día 22 01 2026. Tolerando decubito dorsal plano, sin requerimiento de oxígeno ni disnea, hemodinamia estable, autovalente, deambulando.

Resumen de estudios:

Ecocardio 19/1/26: Acinesia de los segmentos apicales del ventrículo izquierdo. 2. V entrículo izquierdo moderadamente dilatado con función sistólica global levemente disminuida. 3. Disfunción diastólica grado II. 4. Severa dilatación de la aurícula izquierda y derecha dilatada. 5. Cambios degenerativos de válvulas mitral y aórtica, con insuficiencia mitral leve. 6. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica global conservada. 7. Insuficiencia tricuspídea leve (PSAP 30 mmHg). 8. Ateromatosis aórtica. Fracción de eyección: 43%.

CNG del 19/1/26: ADA: De buen calibre y desarrollo, obstrucción de 80% severamente calcificada en su porción media. Ramo diagonal subocluido-ocluido. ACx: De buen calibre y desarrollo, obstrucción de 60% segmento medio

Coronariografía del 21 01 2026. Mismas lesiones ,se realizó: ANGIOPLASTIA EXITOSA DE BIFURCACIÓN DE LA DESCENDENTE ANTERIO, DIAGONAL (CTO DE DG) CON TECNICA DE BIFURCACIÓN, MINIO CRUSHING COIN 2 STENT MEDICADOS IMBRICADOS DE DISTAL A PROXIMAL EN ADA . ORSIRO 3.0 X35 MM y ORSIRO 3,5 x35 mm, y Stent medicado orsiro 2,5x 15 mm a DG. Angioplastia circunflej con stent medicado Orsiro 3,0 x 22mm.

Via radial derecha sin complicaciones, flujo TIMI 3. BUEN FLUJO DISTAL DE LA MANO.

RECIBIO HIDRATACIÓN POSTERIOR A LA CNG. va con control de creatinina en una semana y traerlo a la UCO. Control ambulatorio

RESUMEN DE LABORATORIO:

22 01 2026: NA 141 k: 4,2 CL: 109 HTO: 34% RCTO: 5670 PAQ 210.000 bun 32 CREAT: 1,79

21 01 2026 Bun:28,5 creat: 1,6mg: 1,9 TP: 16,2 BUN:30,5 Ac úrico:6,7 P: 3,9 INR: 1,32 Alb: 2.9 K: 3,9 Na 143 Plaquetas:198.000 rcto: 5,2 hb 11,1 %

Laboratorio 20/1/26: TP 13.7 seg 85% INR 1.08 T¿PA 36.7 Creat 1.64 BUN 27.0 Fosf 3.9 Mg 2.0 Na 142 K 4.53 Cl 109 Hb 11.5 HTC 34.3 leucos 4.87 Plt 180000

Laboratorio del 19/1/26: Hb 11.5 ant 11.6 HTC 33.9 leucos 4.76 ant 4.58 Neutro 59.3 linf 28.5 Plt 183000 ant 151000

Na 147 K 4.39 Cl 109 Mg 2.0 Creat 1.60 ant 1.58 BUN 26.4 TUS 8956.0 ant 11750.2.TP 13.8 84% INR 1.09 TTPA 37.4

FRCV: TSH 2.16 CT 83 HDL 31 LDL 41 TGL 55 HbA1c 7.1.

Fecha Última Actualización: 22-01-2026 12:14:18

Página 3 de 3

Diagnóstico de Egreso

Infarto agudo del miocardio pared anterior - enfermedad coronaria de 2 vasos, susceptible de tto endovascular.
ANGIOPLASTIA EXITOSA DE BIFURCACIÓN DE LA DESCENDENTE ANTERIOR, DIAGONAL (CTO DE DG) CON
TECNIC DE BIFURCACIÓN, MINIO CRUSHING COIN 2 STENT MEDICADOS IMBRICADOS DE DISTAL A PROXIMAL EN ada
. ORSIRO 3.0 X35 MM y ORSIRO 3,5 x35 mm, y Stent medicado orsiro 2,5x 15 mm a DG. Angioplastia circunflej con stent
medicado Orsiro 3,0 x 22mm.
FIBRILACION AURICULAR CRÓNICA
ERC 3B
HTA, DM2 IR, carcinoma escamoso de la cabeza operado, FA paroxística en TACO , pancreatitis complicada 2013

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

SATISFACTORIAS. SIN DOLOR SIN DISNEA , AUTOVALENTE.

Plan Post Alta

1. CONTROL POR CARDIOLOGIA CONSULTA, CDT, PASILLO 8 , HOSPITAL SOTERO DEL RIO.
2. ACUDIR A URGENCIA EN CASO DE DOLOR, SANGRADO; DIFICULTAD RESPIRATORIA U OTRO SINTOMA QUE CONSIDERE DE IMPORTANCIA.
3. NO DEBE SUSPENDER LA ASPIRINA, EL CLOPIDOGREL Y EL APIXABAN PARA EVITAR COMPLICACIONES A SU INFARTO.
- 4 DEBE IR NEFROLOGIA PARA CONSULTA DE CONTROL

QUEDA CON ESQUEMA DE ASPIRINA 100 MG + CLOPIDOGREL+ APIXABAN ESQUEMA TRIPLE POR UNA SEMANA Y LUEGO ABANDONAR LA ASPIRINA Y CONTINUAR CON APIXBAN 5 MG CADA 12horas MAS CLOPIDOGREL 75 MG CADA 24HORAS EN FOIRMA CONTINUA.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos : Omeprazol 20mg 1 Diario
Espironolactona 25mg 1 Diaria
Enalapril 10mg 1/2 Cada 24 Horas.
Empaglifozina 25 Mg 1/2 Diaria
Clopidogrel 75mg 1 Cada 24horas.
Bisoprolol 5 Mg 1/2 Diaria
Atorvastatina 20mg 4 Tabletas Al Día A Las 9pm.
Apixaban 5 Mg Cada 12horas 1 Cada 12h
Acido Acetilsalicílico 100mg 1 Cada 24h

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Luis Sosa Sanchez
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 22/01/2026 12:14

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:22

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar